

Uzależnienie + *depresja*

35–40% osób z uzależnieniem ma depresję. Spirala wzajemnego nasilania. Leczenie obu jednocześnie daje 3× lepsze wyniki niż tylko jednego.

CZAS: 25 min czytanie Psychoedukacja + plan

ŹRÓDŁO: Petitjean i wsp. (2014); Nunes & Levin (2004); APA wytyczne (2017)

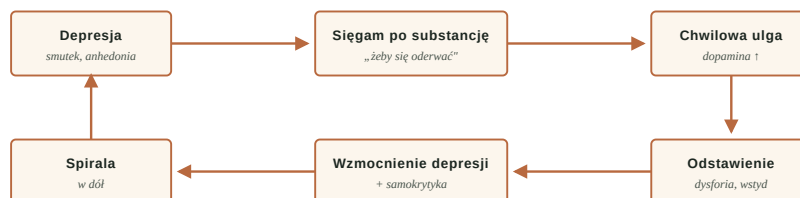
JAK UŻYWAĆ

Karta wyjaśnia **spirale uzależnienie-depresja**: jak oba zaburzenia napędzają się wzajemnie, jak rozróżnić *depresję pierwotną* od *indukowanej substancją*, kiedy leczenie farmakologiczne, kiedy psychoterapeutyczne. Karta obejmuje: 1) **mechanizm spirali**, 2) różnicowanie diagnostyczne (po 4 tyg. abstynencji), 3) opcje terapeutyczne, 4) jak długo leczymy.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Petitjean i wsp. (2014, n=1102) wykazali: **35-40% osób z uzależnieniem alkoholowym** spełnia kryteria epizodu depresyjnego w danym momencie. Sama abstynencja redukuje objawy depresji o 30-50% w 4-8 tyg., ale **30-40% osób ma depresję pierwotną** wymagającą farmakoterapii i psychoterapii niezależnie od używania. Bez rozróżnienia *która depresja*: 1) terapeuci przepisują leki, które działają tylko częściowo, 2) odstawienie leków po krótkim okresie powoduje nawrót depresji + nawrót używania. Nunes & Levin (2004, metaanaliza 14 RCT): SSRI + CBT u osób z **PIERWOTNĄ** depresją daje 50% redukcję objawów; u osób z indukowaną — tylko 15%. Dlatego diagnostyka różnicowa jest kluczowa.

01 ✕ Spirala — jak depresja i uzależnienie nasilają się wzajemnie



02 🌿 Różnicowanie — depresja pierwotna vs indukowana

DEPRESJA PIERWOTNA

- Objawy obecne **przed** rozpoczęciem używania
- Utrzymują się **po 4 tyg. abstynencji**
- Wywiad rodzinny obciążony depresją
- Wcześniejsze epizody depresji niezwiązane z używaniem
- **Leczenie:** SSRI/SNRI + psychoterapia (CBT, IPT)

DEPRESJA INDUKOWANA SUBSTANCJĄ

- Pojawia się **w trakcie** używania lub odstawienia
- Ustępuje w ciągu **2-4 tyg. abstynencji**
- Brak wywiadu osobistego / rodzinnego
- Nasilenie koreluje z intensywnością używania
- **Leczenie:** przede wszystkim abstynencja + psychoterapia uzależnienia

Złoty standard diagnostyczny: diagnozę depresji pierwotnej stawia się zwykle *po 4 tygodniach abstynencji*. W tym okresie nie odstawiamy leków, jeśli już ktoś je bierze — ale diagnoza może być dopiero teraz uznana za pewną. **Wyjątek:** ciężkie myśli samobójcze, hospitalizacja — leczenie farmakologiczne zaczynamy natychmiast, bez czekania.

03 Leczenie — co działa, w jakiej kolejności

OBSZAR	CO STOSUJEMY	UWAGI
<i>Farmakoterapia depresji</i>	SSRI (sertralina, escitalopram) lub SNRI (wenlafaksyna)	Bezpieczne przy abstynencji; działają od 2–4 tyg.
<i>Farmakoterapia uzależnienia</i>	Naltrekson (alkohol), akamprosat (alkohol), nalmefen, ew. disulfiram	Można łączyć z SSRI — bezpieczne
<i>Psychoterapia</i>	CBT zintegrowane (Beck), aktywacja behawioralna, IPT, MBCT	Lepiej u jednego terapeuty znającego oba zaburzenia
<i>Czynniki życiowe</i>	Sen, ruch (30 min × 3/tydz.), światło, dieta	Często niedoceniane — działa silnie i bezpiecznie

04 Mój plan

MÓJ KONTEKST

— który scenariusz: pierwotna, indukowana, jeszcze nie wiem

MÓJ NASTĘPNY KROK

— konsultacja psychiatryczna, lek, terapia, ruch?

UWAGA — myśli samobójcze: u osób z podwójną diagnozą uzależnienie + depresja ryzyko samobójstwa jest **6× wyższe** niż w populacji ogólnej (Wilcox, Conner & Caine 2004). Jeśli pojawiają się myśli o śmierci / samouszkodzenia / „lepiej byłoby gdyby mnie nie było” — natychmiastowa konsultacja psychiatryczna. Linia 116 123 (24h, bezpłatna). W kryzysie — 112.

Klucz: Petitjean i wsp. (2014) wykazali: u osób z podwójną diagnozą uzależnienie + depresja, **zintegrowane leczenie** (farmakoterapia obu + CBT zintegrowane) daje **3× wyższy wskaźnik utrzymania abstynencji i remisji depresji** w 12 miesiącach niż leczenie tylko uzależnienia. Bez leczenia depresji — nawet 70% pacjentów wraca do używania jako sposobu radzenia z dysforią. Wniosek praktyczny: *nie czekać na pełną abstynencję, by zacząć leczyć depresję*. Oba zaburzenia od razu, jednocześnie, najlepiej u tego samego specjalisty.